KI-EINSATZ-PLANUNG · VERORDNUNGS-CHECK · GRUPPE 1

Kapitel 1: Ist- und Soll-Situation beschreiben

Physiotherapiepraxis (anonymisiert) · Endfassung · Stand 28.10.2026

Bevor eine gesetzlich versicherte Patientin in der Physiotherapie behandelt wird, prüft die Rezeption die ärztliche Verordnung Feld für Feld. Diese Prüfung kostet Zeit, verlangt Detailwissen über mehrere Regelwerke und gelingt trotzdem nicht immer. Fehler fallen oft erst bei der Abrechnung auf, wenn die Leistung längst erbracht ist. Dieses Kapitel beschreibt das Unternehmen und seine Rahmenbedingungen, die heutige Prüfung mit den Zahlen aus unserer Field Study und die Ziele, an denen sich der KI-Einsatz messen lassen muss.

1 Das Unternehmen und seine Rahmenbedingungen

Das Unternehmen ist eine Physiotherapiepraxis mit rund zehn Mitarbeitenden an zwei Standorten. Praxis 1 behandelt gesetzlich Versicherte, Praxis 2 Privatpatientinnen und -patienten. Die Terminvergabe läuft zentral für beide Standorte. Die Abrechnung mit den Krankenkassen übernimmt ein externer Abrechnungsdienstleister. Er prüft die Verordnungen dabei ein drittes Mal und kostet die Praxis 1,9 % vom Umsatz.

Ob eine Kassenverordnung gültig ist, regeln öffentliche Vorgaben: die Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses mit Fristen, Pflichtangaben und dem Verordnungsfall, der Heilmittelkatalog mit Höchstmengen und zulässigen Heilmitteln je Diagnosegruppe sowie die Diagnoseliste der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum besonderen Verordnungsbedarf. Grundlage jeder Kassenbehandlung ist das Formular Muster 13. Ist es fehlerhaft, kürzt die Krankenkasse die Vergütung oder setzt sie ganz ab.

KI setzt die Praxis heute in keinem Bereich und an keinem Standort ein. Damit gehört sie zur Mehrheit: Laut Destatis nutzte 2024 jedes fünfte Unternehmen in Deutschland KI, laut einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft 37 % aller und 36 % der kleinen Unternehmen. Die vorhandene Praxissoftware unterstützt die Verarbeitung der Verordnungen, aber nicht die Qualitätssicherung.

Für den Einsatz von KI sprechen in diesem Umfeld zwei Voraussetzungen. Die Regeln sind öffentlich und schriftlich fixiert, ein System kann sie also nachschlagen und jede Aussage belegen. Und die Verordnungen kommen als halb strukturierter Text an, den ein Sprachmodell erfassen kann. Dagegen steht, dass Verordnungen Gesundheitsdaten enthalten und Physiotherapeutinnen der Schweigepflicht unterliegen. Beides bestimmt die Grenzen der Lösung und wird in Kapitel 4 behandelt.

2 Ist-Situation: Ergebnisse der Field Study

Die Zahlen in diesem Kapitel sind nicht geschätzt, sondern erfragt. Am 16.10.2026 haben wir ein einstündiges Interview mit der Mitinhaberin geführt, entlang eines Fragebogens mit 13 Fragen. Die Antworten sind mit Einheit erfasst, also in Minuten, Fällen und Euro. Die Praxis hat der anonymisierten Verwendung zugestimmt. Zwei Fragen fehlten im ersten Bogen: die bisherige KI-Nutzung und die Organisation über zwei Standorte. Wir haben sie am 23.10.2026 als eigenen Nachtrag erhoben, statt das Original nachträglich zu ändern.

Ablauf heute

1. **Annahme:** Die Rezeption prüft eine neue Verordnung, im Schnitt 6 Minuten, je nach Fall 1 bis 10 Minuten.
2. **Behandlung:** Die Leistung wird erbracht.
3. **Schlussprüfung:** Vor der Abrechnung prüft die Rezeption jeden Fall noch einmal, rund 2 Minuten.

4 **Abrechnung:** Der Dienstleister prüft ein drittes Mal und rechnet mit der Kasse ab.

5 **Krankenkasse:** Findet sie einen Fehler, kürzt sie, in der Regel ohne Begründung. Die Praxis muss nachfragen.

ca. 40
neue Kassenverordnungen pro Woche

5,3 h
Prüfzeit pro Woche (40 × 8 min)

90 %
der Fehler bei Doppel- und Folgeverordnungen

≤ 85 %
Wirksamkeit menschlicher Doppelkontrollen

Größe	Wert	Herkunft
Neue Kassenverordnungen	ca. 40 pro Woche	Interview, Frage 5
Prüfzeit je Verordnung	Ø 6 min bei Annahme, ca. 2 min vor der Abrechnung	Interview, Frage 9
Prüfzeit gesamt	40 × 8 min = 320 min ≈ 5,3 h pro Woche	berechnet
Häufigste Fehlerursache	ca. 90 % Doppel- und fehlerhafte Folgeverordnungen	Interview, Frage 3
Absetzungen	ca. 10 Fälle bzw. ca. 500 € pro Jahr, etwa alle zwei Jahre ein Einzelfall bis 700 €	Interview, Frage 1
Vergütung je Einheit	Ø 32 €	Interview, Frage 4
Abrechnungsdienstleister	1,9 % vom Umsatz	Angabe der Praxis (korrigiert, 28.10.2026)
Wirksamkeit von Doppelkontrollen	höchstens ca. 85 %	Einschätzung der Praxis mit Verweis auf Literatur

Was die Zahlen bedeuten

Das Problem ist die Zeit, nicht das Geld bei der Kasse. Mit rund 500 € pro Jahr sind die Absetzungen klein, weil der Dienstleister fast alle übersehenen Fehler noch abfängt. Der Preis dafür ist doppelt: 5,3 Stunden Prüfzeit pro Woche an der Rezeption und eine dauerhafte Abhängigkeit von einer externen Kontrolle.

Die Fehler entstehen dort, wo die Rezeption am wenigsten sieht. Neun von zehn Fehlern betreffen Folge- und Doppelverordnungen. Ob ein Patient beim selben Arzt schon Einheiten im selben Verordnungsfall hatte, zeigt die Praxissoftware nicht an. Die Rezeption prüft das heute aus dem Gedächtnis.

Mehr menschliche Kontrolle löst das nicht. Wenn auch Doppelkontrollen höchstens etwa 85 % der Fehler finden, ist eine weitere Prüfschleife keine Lösung. Gebraucht wird eine Prüfung, die jede Verordnung gleich gründlich gegen die Regeln hält.

Fehler fallen zu spät auf. Wird ein Fehler erst vor der Abrechnung entdeckt, ist die Behandlung bereits erbracht. Eine Korrektur durch den Arzt ist dann aufwendig oder nicht mehr möglich.

3 Soll-Situation

Im Soll-Prozess prüft ein KI-System jede neue Kassenverordnung vor der ersten Behandlung. Die Qualitätssicherung wandert damit an den Anfang des Prozesses.

1 **Verordnung kommt an:** Die Rezeption gibt sie über ein Formular nach Muster 13 oder als Text in einen Chat ein.

2 **Das System prüft in rund 30 Sekunden:** Vier spezialisierte Prüfer kontrollieren Pflichtangaben, Diagnose, Menge und Fristen. Das Ergebnis ist eine Ampel mit Korrekturhinweis und Fundstelle im

Regelwerk.

3. **Die Rezeption entscheidet:** behandeln, beim Arzt nachfragen oder die Verordnung korrigieren lassen. Das System weist nichts automatisch ab.
4. **Die Schlussprüfung entfällt schrittweise,** aber erst, wenn ein Parallelbetrieb bestanden ist.

Der wichtigste Ausbau ist die Verordnungsfall-Prüfung. Das System summiert die Einheiten aller früher geprüften Verordnungen desselben Falls und macht damit sichtbar, was die Praxissoftware heute nicht zeigt. Genau dort entstehen 90 % der Fehler.

4 Ziele und Erfolgsindikatoren

Die Ziele sind so formuliert, dass sie in Kapitel 5 als Kontrollmaßstab dienen.

Ziel	Erfolgsindikator	Messung
Zeit	Prüfzeit −50 % nach zwei Quartalen, −75 % nach vier Quartalen	Stoppuhr-Stichprobe vorher und nachher
Qualität	≥ 98 % richtige Ampeln, keine übersehene rote Verordnung	Evaluation mit mindestens 50 neuen Fällen, je drei Läufe
Vertrauen	höchstens ein kritischer Fehlalarm	Evaluation und Abweichungsprotokoll im Parallelbetrieb
Akzeptanz	Die Rezeption folgt der Ampel	Quote im Pilot, Rückmeldungen der Rezeption

Der Zielwert von 98 % ist bewusst hoch gewählt. Er ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber höchstens 85 % bei menschlicher Doppelkontrolle.

5 Business Case

Der Business Case beruht auf der eingesparten Prüfzeit. Die Absetzungen von rund 500 € pro Jahr und die Kosten des Dienstleisters rechnen wir bewusst nicht ein: Die Absetzungen sind klein, und ob sich am Dienstleister etwas ändern lässt, ist offen. Beides ist ein möglicher Zusatznutzen, kein Teil der Rechnung.

Annahmen

Größe	Wert	Herkunft
Prüfzeit heute	5,3 h pro Woche	Field Study
Einsparziel	50 % nach zwei, 75 % nach vier Quartalen; Anlauf Q1 25 %, Q2 50 %, Q3 62,5 %, Q4 75 %	Annahme des Teams
Stundenlohn Rezeption	15,99 € = Mindestlohn 2026 (13,90 €) + 15 %	Mindestlohn: Bundesregierung; Zuschlag: Annahme. Marktvergleich Rezeption 12,77–15,36 €/h
Arbeitgeberkosten je Stunde	20,97 € = 15,99 € × 1,3117	Pauschalabgaben gewerblicher Minijob bis 31,17 %
Minijob	max. 603 € pro Monat ≈ 8,7 h pro Woche; mit Abgaben ≈ 9.500 € pro Jahr	Verdienstgrenze 2026

Die Pauschalabgaben setzen sich zusammen aus Krankenversicherung 13 %, Rentenversicherung 15 %, Pauschsteuer 2 % sowie den Umlagen U1 0,8 %, U2 0,22 % und Insolvenzgeld 0,15 %. Die Unfallversicherung ist nicht enthalten; die Rechnung ist dadurch leicht konservativ.

Rechenweg

Je Quartal fallen 5,3 h × 13 Wochen = 68,9 Prüfstunden an. Im ersten Jahr steigt die Einsparung entlang der Anlaufkurve, ab dem zweiten Jahr bleibt sie bei 75 %.

Zeitraum	Einsparung	Freie Stunden	Wert
Jahr 1, Q1	25 %	17,2 h	
Jahr 1, Q2	50 %	34,5 h	
Jahr 1, Q3	62,5 %	43,1 h	
Jahr 1, Q4	75 %	51,7 h	
Jahr 1 gesamt		**146,4 h**	**≈ 3.070 €**
ab Jahr 2, pro Jahr	**75 %**	**206,7 h**	**≈ 4.300 €**

Ab dem zweiten Jahr werden damit rund vier Stunden pro Woche frei, etwa ein halber Minijob.

> **Einordnung**
>
> **Keine Doppelzählung:** Die freien Stunden sind der halbe Minijob, kein zusätzlicher Effekt. **Vermeiden statt ersetzen:** Ziel ist nicht, eine Stelle abzubauen, sondern bei Wachstum keinen zusätzlichen Minijob zu brauchen und an der Rezeption Zeit für Patienten und Telefon zu gewinnen. **Weicher Nutzen:** weniger Rückfragen beim Arzt nach der Behandlung und weniger Ärger über Absetzungen sind real, aber nicht in Euro bewertet; im Pilot erfassen wir sie über Rückmeldungen der Rezeption.
>
> **Sensitivität:** Mit dem Mindestlohn 2027 von 14,60 € steigt die Ersparnis ab Jahr 2 auf ca. 4.550 € pro Jahr. Erreicht die Praxis nur 50 % statt 75 % Einsparung, sind es ca. 2.890 € pro Jahr. **Gegenzurechnen** sind die Betriebskosten: Die Modellkosten liegen bei 70 bis 142 € pro Jahr (Kapitel 3), dazu kommen die Abonnements für n8n und Supabase von rund 240 € (n8n) und rund 300 US-Dollar (Supabase) pro Jahr. Netto bleiben ab Jahr 2 damit rund 3.600 bis 3.700 € pro Jahr..

Damit ist klar, welches Problem gelöst werden soll und woran der Erfolg zu messen ist. Ob der Verordnungs-Check tatsächlich der beste Ansatzpunkt für KI in der Praxis ist, prüft Kapitel 2.

QUELLEN

- Eigene Field Study: Ist-Interview mit der Mitinhaberin am 16.10.2026 (Fragebogen F01–F13) und Nachtrag vom 23.10.2026
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog; Kassenärztliche Bundesvereinigung: Diagnoseliste Heilmittel, Stand 01.01.2026
- Destatis und Institut der deutschen Wirtschaft, zitiert nach IHK-Rahmenplan „KI-Tool-Experte/Expertin (IHK)“
- Bundesregierung: Mindestlohn jetzt bei 13,90 Euro, bundesregierung.de
- n8n und Supabase: Preisseiten, abgerufen am 27.10.2026 (siehe Kapitel 3)
- Lohndialog: Minijob-Lohnabrechnung 2026, lohndialog.de, abgerufen am 26.10.2026; gehalt.de (Marktvergleich Rezeption)